Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Exérèse de la glande sous-mandibulaire

Ablation de la glande salivaire située sous la mâchoire

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Côté : ☐ Droit ☐ Gauche

Motif de l'intervention : ☐ Calcul salivaire / infections à répétition ☐ Grosseur dans la glande ☐ Autre _____

Monitorage nerveux : ☐ Sera utilisé ☐ Ne sera pas utilisé

Résultat de l'imagerie / de la biopsie : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

La glande sous-mandibulaire est une glande salivaire située juste sous la mâchoire inférieure, de chaque côté, qui libère de la salive dans la bouche. Elle produit une part importante de la salive ; toutefois, comme la glande du côté opposé ainsi que les glandes salivaires situées devant les oreilles et sous la langue continuent de fonctionner, **l'ablation d'une seule glande ne provoque pas de sécheresse de la bouche chez la plupart des patients**.

Cette intervention est le plus souvent réalisée en raison de **calculs des glandes salivaires** et des **gonflements et infections à répétition** qu'ils provoquent. Un calcul bloque l'écoulement de la salive vers la bouche, ce qui entraîne un gonflement douloureux sous la mâchoire pendant les repas et des infections répétées. Moins souvent, une **grosseur (tumeur)** dans la glande nécessite une intervention. La proportion de tumeurs malignes est plus élevée parmi les grosseurs de la glande sous-mandibulaire que parmi celles de la parotide ; il est donc important de retirer la glande et de l'examiner au microscope pour établir un diagnostic définitif.

Trois nerfs passent à proximité de la glande : la branche nerveuse qui fait bouger la lèvre inférieure, le nerf qui assure la sensibilité de la langue et le nerf qui fait bouger la langue. Le but de l'intervention est d'enlever complètement la glande tout en préservant ces nerfs.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Comment se déroule l'intervention ?

L'intervention est réalisée sous anesthésie générale, au bloc opératoire.

1. **Incision :** Une incision, généralement de 4 à 6 cm de long, est pratiquée environ 2 à 3 cm sous l'os de la mâchoire, parallèlement à un pli naturel de la peau du cou. Placer l'incision suffisamment bas sous la mâchoire aide à protéger la branche nerveuse qui fait bouger la lèvre inférieure.
2. **Protection des nerfs :** La fine couche musculaire située sous la peau (platysma) est ouverte. La branche nerveuse qui fait bouger la lèvre inférieure (rameau marginal de la mandibule) est protégée, soit en la visualisant, soit en restant dans un plan tissulaire sûr.
3. **Ablation de la glande :** La glande est séparée des tissus environnants et les vaisseaux qui l'irriguent sont ligaturés. Le canal salivaire est séparé avec précaution du nerf qui assure la sensibilité de la langue (nerf lingual), puis ligaturé et sectionné. Le nerf qui fait bouger la langue (nerf hypoglosse) est préservé. S'il y a un calcul dans le canal, la partie éloignée du canal est également retirée autant que possible.
4. **Examen anatomopathologique :** La glande retirée est envoyée au laboratoire d'anatomopathologie ; le résultat est généralement disponible dans un délai de 1 à 2 semaines.
5. **Fermeture :** Le saignement est contrôlé, un fin **drain** est généralement mis en place et la peau est refermée par des points esthétiques.

S'il y a un calcul dans la bouche, près de l'endroit où le canal s'ouvre, il peut parfois aussi être retiré séparément par voie endobuccale (par l'intérieur de la bouche). Cela sera discuté avec vous avant l'intervention.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie générale	Environ 1 à 2 heures	Généralement 1 nuit ; sortie après le retrait du drain

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Fin des gonflements douloureux et des infections à répétition dus aux calculs
- Plus besoin de cures d'antibiotiques répétées
- Ablation d'une grosseur de la glande et diagnostic définitif

Après une intervention pour calculs et infection chronique, les symptômes disparaissent complètement chez **plus de 90 %** des patients. Si un calcul reste ou se reforme dans la partie du canal laissée dans la bouche, un gonflement du plancher buccal peut rarement persister. Pour les grosseurs bénignes, l'intervention permet généralement une guérison définitive ; les tumeurs malignes peuvent nécessiter un traitement complémentaire.

4 Autres options thérapeutiques

- **Traitement médical et mesures de soutien :** Boissons abondantes, aliments acides pour stimuler la salivation, massages, compresses chaudes et antibiotiques pendant les infections. Cela peut soulager les symptômes mais ne supprime pas le calcul.
- **Extraction du calcul par la bouche :** Les calculs situés dans la partie du canal proche de la bouche et palpables peuvent être retirés par une petite incision à l'intérieur de la bouche, en conservant la glande.
- **Endoscopie des canaux salivaires (sialendoscopie) :** Les calculs de taille et de position adaptées peuvent être retirés de l'intérieur du canal à l'aide d'un fin endoscope ; cette technique n'est pas disponible dans tous les centres et ne convient pas à tous les calculs.
- **Surveillance :** Pour les petites grosseurs considérées comme bénignes, une surveillance peut rarement être envisagée ; toutefois, pour cette glande, une intervention est généralement recommandée afin d'établir un diagnostic définitif.

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Sans intervention, les gonflements et les infections dus aux calculs peuvent continuer à se répéter ; rarement, un abcès (collection de pus) peut se former autour de la glande et nécessiter un traitement en urgence. En cas de

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

grosseur dans la glande, aucun diagnostic définitif ne peut être posé ; une tumeur maligne non traitée peut progresser.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Avant l'intervention, des analyses de sang et une imagerie (échographie et, si nécessaire, scanner/IRM) sont réalisées ; vous serez examiné(e) par le médecin anesthésiste.
- Vous ne devez ni manger ni boire pendant les **6 à 8 heures** précédant l'intervention (veuillez suivre les consignes du médecin anesthésiste).
- Si la glande est le siège d'une infection active, l'intervention est généralement programmée une fois l'infection traitée.
- Chez les hommes, la barbe dans la zone d'incision peut être raccourcie le jour de l'intervention.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Premières 24 à 48 heures	Vous ressentirez une douleur légère à modérée, une sensation de tiraillement et un gonflement sous la mâchoire, soulagés par des antalgiques. Avaler peut être légèrement inconfortable. Le drain est généralement retiré le 1er jour. Il est recommandé de dormir la tête surélevée. Vous pouvez commencer à manger des aliments mous immédiatement.
1re semaine	Vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes. Les points sont généralement retirés **entre le 5e et le 7e jour**. Un engourdissement au-dessus de l'incision, le long de la mâchoire et autour de l'incision est normal. Le résultat de l'anatomopathologie vous sera communiqué pendant cette période ou peu après.
2e à 4e semaine	La plupart des personnes reprennent un travail de bureau en 1 semaine. Le sport intense et le port de charges lourdes doivent être reportés d'environ **2 semaines**. L'induration et le léger gonflement au niveau de l'incision diminuent progressivement.
2e à 6e mois	La cicatrice s'estompe progressivement et devient souvent peu visible dans le pli du cou. Une éventuelle faiblesse nerveuse ou diminution de sensibilité temporaire récupère généralement au cours de cette période.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Douleur, tiraillement et gonflement sous la mâchoire ; léger inconfort en avalant
- Engourdissement de la peau autour et en dessous de l'incision
- Une cicatrice dans le cou (s'estompe avec le temps)

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Faiblesse temporaire de la lèvre inférieure** — En raison de l'étirement, pendant l'intervention, de la branche nerveuse qui abaisse la lèvre inférieure (rameau marginal de la mandibule), environ **10 à 20 patients sur 100** présentent une légère asymétrie de la lèvre inférieure de ce côté en souriant ou en parlant. Il s'agit d'un problème esthétique, qui n'affecte généralement pas le fait de manger ou de boire et qui, le plus souvent, **s'améliore en quelques semaines à quelques mois**.
- **Induration et engourdissement au niveau de l'incision** — Une induration et une diminution de la sensibilité sous l'incision sont fréquentes au cours des premières semaines et diminuent au fil des mois.

Situations peu fréquentes

- **Saignement et hématome** — Chez environ **1 à 3 patients sur 100**, du sang peut s'accumuler sous la peau. S'il est important, il peut être nécessaire de l'évacuer et d'arrêter le saignement au bloc opératoire.
- **Infection de la plaie** — Peut survenir chez **1 à 3 patients sur 100**, en particulier si la glande était infectée ; elle guérit généralement avec des antibiotiques et, rarement, un drainage est nécessaire.
- **Diminution de la sensibilité d'un côté de la langue** — En raison d'une atteinte du nerf qui assure la sensibilité de la langue (nerf lingual), un engourdissement ou des fourmillements de ce côté de la langue surviennent chez environ **1 à 3 patients sur 100**. Ils sont le plus souvent temporaires ; rarement, ils peuvent être permanents et peuvent aussi affecter le goût.
- **Accumulation de liquide (sérome)** — Liquide s'accumulant sous l'incision ; se résorbe généralement grâce à une ponction à l'aiguille et un pansement compressif.
- **Calcul restant dans le canal** — Un calcul peut rester ou se reformer dans la partie du canal salivaire laissée dans la bouche et provoquer un gonflement ou une infection du plancher buccal. Si nécessaire, il est retiré par la bouche au moyen d'un petit geste.
- **Cicatrice visible ou épaisse** — Selon la prédisposition de chacun, la cicatrice peut s'épaissir ou rester visible ; des traitements des cicatrices peuvent être utilisés.
- **Creux sous la mâchoire** — Un léger creux à l'emplacement de la glande et une différence entre les deux côtés peuvent apparaître ; ils ne sont généralement pas visibles.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Faiblesse permanente de la lèvre inférieure** — Chez **environ 1 à 3 patients sur 100** ou moins, une diminution permanente de la mobilité de la lèvre inférieure de ce côté et un sourire asymétrique peuvent persister. Si cela est visible, des traitements tels que la toxine botulique pour équilibrer l'autre côté peuvent être utilisés.
- **Faiblesse des mouvements de la langue** — Une lésion du nerf qui fait bouger la langue (nerf hypoglosse) est **très rare**. Si elle survient, il peut y avoir une faiblesse de ce côté de la langue et des difficultés pour parler et avaler ; en cas d'atteinte permanente, une rééducation de la parole et de la déglutition peut être nécessaire.
- **Hématome important du cou affectant les voies respiratoires** — Très rarement, une accumulation de sang qui augmente rapidement peut comprimer le cou et provoquer des difficultés à avaler ou à **respirer**. Il s'agit d'une urgence : l'hématome doit être évacué immédiatement au bloc opératoire et, rarement, il peut être nécessaire de sécuriser les voies respiratoires (intubation ou trachéotomie).

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Résultat anatomopathologique définitif différent du diagnostic préliminaire** — Même dans une glande que l'on pense atteinte de calculs ou d'infection, l'examen anatomopathologique définitif peut révéler une tumeur inattendue. Si une tumeur maligne est découverte, des traitements complémentaires tels que l'ablation des ganglions lymphatiques du cou ou une radiothérapie peuvent être nécessaires.
- **Sécheresse de la bouche** — L'ablation d'une seule glande passe inaperçue chez la plupart des patients ; toutefois, une sécheresse de la bouche peut devenir perceptible chez les patients ayant reçu une radiothérapie, atteints de certaines maladies rhumatismales ou prenant des médicaments qui assèchent la bouche.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.
- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Gonflement du cou qui augmente rapidement**, surtout s'il s'accompagne de **difficultés à respirer ou à avaler** (urgence — appelez immédiatement le 112)
- **Saignement qui ne s'arrête pas** au niveau du drain ou de la plaie
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C**, rougeur, douleur ou chaleur croissante, ou écoulement de pus au niveau de la plaie
- Gonflement marqué de la langue ou du plancher buccal
- **Difficulté nouvelle et marquée** pour parler ou avaler

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Gardez la plaie au sec pendant les 48 premières heures ; ensuite, vous pouvez prendre une courte douche selon les consignes qui vous ont été données.
- Les premiers jours, privilégiez des aliments mous et tièdes ; veillez à votre hygiène bucco-dentaire et buvez abondamment.
- Protégez la cicatrice du soleil pendant au moins 6 mois (crème solaire à indice de protection élevé).
- Veillez à discuter du résultat anatomopathologique et du plan de suivi avec votre médecin.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.

☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ Je comprends que le diagnostic définitif sera posé par l'examen anatomopathologique après l'intervention et qu'un traitement complémentaire pourra être nécessaire en fonction du résultat.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien de parenté :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.